

Desidratação · classificação e TRO

Classifique pela clínica, prefira terapia de reidratação oral (TRO) quando possível e reserve EV para choque ou falha da via oral.

Escada prática: leve !' moderada !' grave / choque.



Classificação clínica (visão de prova)

| **Leve** | **Moderada** | **Grave**

Estado geral | Alerta, inquieto | Irritado / sonolento | Letárgico / choque

Olhos / fontanela | Normais | Fundos | Muito fundos

Lágrimas / mucosa | Presentes / úmida | !" lágrimas / seca | Ausentes / muito seca

Turgor | Normal | Diminuído | Sinal da prega

Diurese | Normal / !" leve | Reduzida | Oligúria / anúria

Conduta-resumo

- Leve/moderada sem vômitos incoercíveis: TRO com SRO (OMS) em pequenos volumes frequentes
- Manter aleitamento; evitar sucos e refrigerantes como 'reidratação'
- Grave / choque: acesso EV, expansão conforme protocolo (ex.: SF 0,9% em bolus) e reavaliação
- Zinco em diarreia aguda (quando indicado pela diretriz) e orientar sinais de alarme

Plano A / B / C (MS)

Lembre - Plano A / B / C (MS)

Plano A: prevenção da desidratação em casa. Plano B: TRO supervisionada na unidade. Plano C: reidratação venosa na desidratação grave.

Armadilha

Atenção - Armadilha

Criança 'só um pouco quieta' com pulso fino e extremidades frias pode já estar em choque — trate como grave.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Planos A/B/C do MS e a classificação clínica de desidratação são clássicos de R1: definem TRO vs EV e o local de cuidado.

Plano A em casa; B = TRO supervisionada; C = reidratação EV na desidratação grave/choque.

Planos MS - desidratacao

A / B / C

Plano A

Sem desidratacao
SRO apos cada evacuacao
Manter alimentacao

Domicilio

Plano B

Desidratacao
TRO 4h supervisionada
Reavaliar e decidir

URS / UPA

Plano C

Grave / choque
SF 0,9% EV em bolus
Internacao

Urgencia

Quanto mais sinais de gravidade, mais próximo do Plano C.

Sinais de classificacao

Clinica guia o plano

- 1 Estado geral (alerta vs letargico)
- 2 Olhos / fontanela (fundos)
- 3 Lagrimas e mucosas
- 4 Turgor / sinal da prega
- 5 Diurese e sede
- 6 Enchimento capilar / pulso

Choque = Plano C imediato

Classificação clínica (prova)

Sinal | Leve | Moderada | Grave

Estado geral | Alerta | Irritado/sonolento | Letárgico/choque

Olhos/fontanela | Normais | Fundos | Muito fundos

Lágrimas/mucosa | Presentes/úmida | !" / seca | Ausentes/muito seca

Turgor | Normal | Diminuído | Prega persistente

Diurese | Normal/!" leve | Reduzida | Oligúria/anúria

Conduta-chave

- Preferir SRO/OMS em pequenos volumes frequentes (Plano A/B)
- Manter aleitamento; evitar sucos/refrigerantes como reidratação
- Plano C: acesso EV, SF 0,9% em bolus e reavaliação contínua
- Zinco na diarreia aguda quando indicado (protocolo OMS/MS)

Armadilha

Atencao - Armadilha

Criança 'só quietinha' com pulso fino e extremidades frias já pode estar em choque — trate como Plano C, não espere anúria.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1